

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC LORATADIN

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

1. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Mỗi 5 ml dung dịch uống chứa:

Thành phần hoạt chất: Loratadin..... 5 mg

Thành phần tá dược: Sorbitol liquid (70%), natri benzoat, propylen glycol, glycerol, saccharin, acid citric, tutti frutti flavour, nước tinh khiết.

2. DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch uống.

Mô tả sản phẩm: Chế phẩm trong suốt, không màu, không cặn, đựng trong chai PET sạch, kín.

3. CHỈ ĐỊNH:

Dung dịch uống Loratadin được chỉ định để điều trị chứng viêm mũi dị ứng và nổi mề đay vô căn mạn tính ở người lớn và trẻ em trên 2 tuổi.

4. LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

* Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

10 ml (10 mg) x 1 lần/ ngày.

Trẻ em:

Trẻ em từ 2 – 12 tuổi, được tính theo trọng lượng:

+ Cân nặng ≥ 30 kg: 10 ml (10 mg) x 1 lần/ ngày.

+ Cân nặng < 30 kg: 5 ml (5 mg) x 1 lần/ ngày.

+ Hiệu quả và an toàn ở trẻ em dưới 2 tuổi chưa được thiết lập.

Bệnh nhân suy gan:

Bệnh nhân suy gan nặng nên dùng liều ban đầu thấp hơn vì có thể giảm độ thanh thải của loratadin.

Nên dùng liều ban đầu 10 ml/ ngày cho người lớn và trẻ em có cân nặng ≥ 30 kg và đối với trẻ em cân nặng < 30 kg, nên dùng 5ml/ ngày.

Bệnh nhân suy thận/ người cao tuổi:

Không cần điều chỉnh liều ở người cao tuổi hoặc bệnh nhân suy thận.

* Cách dùng:

Dùng đường uống. Trong hộp có kèm cốc đong thể tích để dễ dàng chia liều.

Loratadin có thể dùng chung hoặc cách xa bữa ăn, không phụ thuộc vào thời điểm bữa ăn.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân quá mẫn cảm với hoạt chất loratadin hoặc bất cứ thành phần tá dược nào của thuốc.

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Thận trọng khi sử dụng loratadin ở bệnh nhân suy gan nặng.
- Ngưng sử dụng loratadin tối thiểu 48 giờ trước khi thực hiện các xét nghiệm liên quan đến da vì thuốc kháng histamin có thể che dấu hoặc làm giảm các phản ứng dương tính với các chỉ số xét nghiệm da.
- Sorbitol là nguồn dinh dưỡng giàu fructose. Nếu bệnh nhân (hoặc bệnh nhi) được chẩn đoán có rối loạn dung nạp với một số loại đường nhất định, hoặc nếu bệnh nhân bị rối loạn không dung nạp fructose do di truyền, một rối loạn di truyền hiếm gặp, mà bệnh nhân không thể tiêu hóa fructose, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này. Sorbitol có thể gây những triệu chứng tiêu hóa khó chịu và cho tác dụng nhuận trường nhẹ.



- Thuốc này có chứa dưới 1 mmol (23mg) natri trong mỗi đơn vị phân liều, về cơ bản được xem như “không chứa natri”.
- Thuốc có chứa 500 mg propylen glycol trong mỗi 5ml dung dịch uống.

7. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

* *Phụ nữ có thai:*

- Một lượng lớn dữ liệu trên phụ nữ có thai (hơn 1000 trường hợp) cho thấy không có độc tính dị tật cũng như độc tính trên thai nhi của loratadin.
- Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra tác động có hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản.
- Biện pháp phòng ngừa, tốt nhất không nên sử dụng loratadin trong giai đoạn có thai.

* *Phụ nữ cho con bú:*

Loratadin được bài tiết qua sữa mẹ, do đó không khuyến cáo sử dụng loratadin ở phụ nữ cho con bú.

* *Khả năng sinh sản:*

Không có dữ liệu về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ.

8. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Trong các nghiên cứu lâm sàng, loratadin không có hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, bệnh nhân cần biết rằng có một vài trường hợp hiếm gặp bị tình trạng ngủ gà có thể ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ CỦA THUỐC:

- Khi dùng đồng thời với rượu, loratadin không có tác dụng mạnh như đo được ở các nghiên cứu tâm thần vận động.
- Tương tác với tất cả các chất ức chế CYP3A4 hoặc CYP2D6 dẫn đến tăng nồng độ loratadin, có thể gây gia tăng các tác dụng không mong muốn.
- Các thử nghiệm lâm sàng được kiểm soát cho thấy có sự gia tăng nồng độ loratadin trong huyết tương đã được báo cáo sau khi sử dụng đồng thời với ketoconazol, erythromycin và cimetidin, nhưng không có thay đổi đáng kể (bao gồm cả điện tâm đồ).
- Trẻ em: Nghiên cứu tương tác chỉ được thực hiện ở người lớn.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

10. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Tóm tắt hồ sơ an toàn

- Trong các thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, các phản ứng bất lợi thường gặp được báo cáo vượt quá giả dược là đau đầu (2,7%), hồi hộp (2,3%) và mệt mỏi (1%).
- Trong các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến người lớn và thanh thiếu niên trong một loạt các chỉ định bao gồm viêm mũi dị ứng (AR) và nổi mề đay vô căn mạn tính (CIU), với liều khuyến cáo là 10 mg mỗi ngày, các phản ứng bất lợi với loratadin đã được báo cáo ở 2% số bệnh nhân vượt quá điều trị với giả dược. Các phản ứng bất lợi thường gặp nhất được báo cáo vượt quá giả dược là buồn ngủ (1,2%), đau đầu (0,6%), tăng sự thèm ăn (0,5%) và mất ngủ (0,1%).

Bảng tóm tắt các phản ứng có hại được phân nhóm theo tần suất:

Rất thường gặp ($ADR \geq 1/10$), thường gặp ($1/100 \leq ADR < 1/10$), ít gặp ($1/1000 \leq ADR < 1/100$), hiếm gặp ($1/10000 \leq ADR < 1/1000$) và rất hiếm gặp ($ADR < 1/10000$).

Trong mỗi nhóm tần số, các phản ứng bất lợi được trình bày theo thứ tự giảm dần mức độ nghiêm trọng.

Hệ cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn hệ thống miễn dịch	Rất hiếm gặp	Phản ứng quá mẫn (bao gồm phù mạch và sốc phản vệ)
Rối loạn hệ thần kinh	Rất hiếm gặp	Chóng mặt, co giật
Tim mạch	Rất hiếm gặp	Nhịp tim nhanh, đánh trống ngực
Rối loạn tiêu hóa	Rất hiếm gặp	Buồn nôn, khô miệng, viêm dạ dày
Gan mật	Rất hiếm gặp	Chức năng gan bất thường
Da và mô dưới da	Rất hiếm gặp	Phát ban, rụng tóc
Rối loạn toàn thân và tại chỗ	Rất hiếm gặp	Mệt mỏi
Khảo sát	Chưa xác định	Tăng cân

- Trẻ em: Trong các nghiên cứu lâm sàng ở trẻ em từ 2-12 tuổi, các tác dụng không mong muốn lớn hơn giả dược là đau đầu (2,7%), hồi hộp (2,3%) và mệt mỏi (1%).

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp các tác dụng không mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia.

11. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Quá liều loratadin làm tăng sự xuất hiện của các triệu chứng kháng cholinergic. Các triệu chứng như tình trạng buồn ngủ, nhịp tim nhanh và đau đầu đã được báo cáo khi dùng quá liều loratadin.
- Điều trị quá liều loratadin thông thường bao gồm điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ, bắt đầu ngay và duy trì chừng nào còn cần thiết. Dùng than hoạt tính để ngăn chặn sự hấp thu của loratadin, cần xem xét việc rửa dạ dày. Loratadin không được loại bỏ bằng phương pháp thẩm tách máu và người ta không biết liệu loratadin có được loại bỏ bằng thẩm tách màng bụng hay không. Cần tiếp tục chăm sóc y tế cho bệnh nhân sau khi được điều trị khẩn cấp.

12. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Chai nhựa PET. Chai 30 ml, 60 ml, 90 ml – Hộp 1 chai, kèm theo 1 cốc chia liều.

13. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, 30 ngày sau mở nắp.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

14. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC:



MEBIPHAR

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Lô III – 18, đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025

Đại diện hợp pháp cơ sở đăng ký

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Signature)

Ds. HUYNH THỊ DIỆU HIỀN